ATIVIDADE XIII • CRESCIMENTO, VIABILIDADE E COERÊNCIA

Crescer com evidências. Escalar com responsabilidade.

Plano de crescimento do PetCuida: validação local antes de expansão.

Gabriel da Silva Cassino • Giovanna Naves Ribeiro

Júlia Rodrigues Vasconcellos Melo • Kathleen Rodrigues Leite Barbosa

Diagnóstico: protótipo em validação.

O que existe

Aplicativo Alpha 3i com perfil, calendário, triagem informativa e rede demonstrativa.

Evidência disponível

Cinco sessões qualitativas conduzidas com apoio da equipe.

O que ainda não existe como evidência

Tração comercial, receita validada, parceiros contratados ou retenção comprovada.

Estratégia 1 — piloto territorial assistido.

Descoberta • semanas 1–2

Entrevistar 15–20 tutores; conversar com 5 clínicas e 2 organizações.

Revisão • semanas 3–4

Corrigir créditos/QR Code e realizar 10 testes sem ajuda.

Piloto • semanas 5–8

Convidar até 40–50 tutores e buscar 2–3 clínicas, condicionado à adesão.

Estratégia 2 — aquisição local baseada em confiança.

Conteúdo preventivo

Informação útil e comunicação clara sobre os limites da triagem.

Indicação por parceiros

Começar com organizações locais e clínicas que aceitem participar.

Mensuração por canal

Usar links/QR distintos e acompanhar cadastro, ativação e retorno.

Escalar processos antes de escalar território.

Padronizar

Cadastro de parceiros, serviços, horários, critérios e encaminhamentos.

Automatizar depois de aprender

Automatizar tarefas repetitivas que já funcionem manualmente.

Proteger dados

Minimizar coleta, controlar acessos, definir retenção, backup e resposta a incidentes.

Metas do piloto: indicadores para aprender, não promessas.

60%

ativação proposta

30%

retenção no dia 30

8/10

testes sem ajuda

2

clínicas interessadas em repetir

Definições: ativação = perfil + primeiro lembrete em 7 dias; retenção = ação relevante entre os dias 22 e 30.

Metas propostas; resultados reais deverão ser reportados como contagens e taxas observadas.

Viabilidade: medir antes de projetar receita.

Custos a registrar

Hospedagem, comunicação, pagamentos, suporte e horas da equipe.

Hipóteses de receita

Planos para parceiros, intermediação e convênios/patrocínios — ainda não validados.

Critério econômico

Avançar somente quando margem, custos e capacidade operacional forem compreendidos.

Modelo econômico para preencher com dados reais.

Receita mensal potencial

$$Rm = (Nc \times Pc) + (Na \times Ta) + S$$

Nc: clínicas pagantes • Pc: plano mensal • Na: atendimentos concluídos • Ta: receita líquida por atendimento • S: patrocínio/convênio formal

Ponto de equilíbrio aproximado: Neq = custos fixos mensais ÷ margem de contribuição por parceiro.

Equações de análise futura — sem preços, custos ou receita observados no material disponível.

Riscos críticos e salvaguardas.

Oferta insuficiente

Validar disponibilidade e critérios antes de divulgar encaminhamentos.

Triagem confundida com diagnóstico

Aviso explícito e encaminhamento profissional em situações urgentes.

Dados e economia

Minimizar dados pessoais; medir custos e margem antes de ampliar.

Decidir com evidências — continuar, iterar ou ampliar.

CONTINUAR

Uso e oferta local mostram sinais positivos.

ITERAR

Dúvidas de uso, retorno baixo ou fluxo pouco claro.

NÃO ESCALAR AINDA

Oferta, segurança ou margem não sustentam expansão.

A expansão deve seguir evidências de comportamento, disponibilidade de parceiros, custos, segurança e capacidade de suporte.